SEMINAR SEKOLAH PASCASARJANA IPB · PROGRAM STUDI ILMU GIZI · SENIN, 2 NOVEMBER 2026

Pengembangan Media Edukasi Gizi Online SHINING bagi Calon Pengantin

Evaluasi Proses Implementasi dan Pola Penggunaan Media Sosial

Marhamah[1], Hardinsyah[2], Cesilia Meti Dwiriani[2], Lilik Kustiyah[2], Irman Hermadi[3]

[1]Program Doktor Ilmu Gizi, FKGiz IPB • [2]Program Studi Ilmu Gizi, FKGiz IPB • [3]Program Studi Ilmu Komputer, FMIPA IPB

Program Studi Ilmu Gizi, FKGiz IPB, Kampus IPB Dramaga, Bogor
0813-8172-4884
am_marhamah@apps.ipb.ac.id

SHINING
Sehat Sebelum Hamil itu Penting
Edukasi gizi prakonsepsi online 8 minggu berbasis *Health Belief Model* (HBM)

Abstrak

Latar belakang. Bukti penggunaan media sosial (medsos) calon pengantin (catin) dan kinerja edukasi gizi prakonsepsi online di Indonesia masih terbatas.

Tujuan. Mengevaluasi implementasi platform web SHINING kelompok kontrol serta menganalisis penggunaan medsos catin dan hubungannya dengan pengetahuan gizi prakonsepsi, sikap berbasis HBM, dan IMT.

Metode. *Cross-sectional* dan evaluasi proses; data awal catin Kota Binjai (Juli–Oktober 2026): 198 pendaftar, 74 dengan data lengkap.

Hasil. Hanya 38,9% menyelesaikan keenam instrumen; penurunan terbesar sebelum tes pengetahuan 48 butir. Kiriman ganda 13,8%; blok makanan pokok hilang pada 26,9% FFQ. WhatsApp dominan (59,5%). Pengetahuan baik 59,5% dan berkorelasi dengan sikap (r=0,414), namun 51,4% berat badan lebih/obesitas. IMT lebih rendah berhubungan dengan durasi medsos lebih lama (r=−0,331) dan sumber akun tenaga kesehatan; memeriksa kebenaran informasi berhubungan dengan sikap lebih positif (r=0,287).

Simpulan. Edukasi online perlu mengarahkan catin ke sumber kredibel dan membiasakan verifikasi informasi; platform perlu instrumen ringkas, konfirmasi penyimpanan di server, dan uji coba pada kelompok sasaran.

Kata kunci: calon pengantin, edukasi online, evaluasi proses, gizi prakonsepsi, media sosial

1 Pendahuluan

Latar belakang

±50% orang dewasa Indonesia berat badan lebih/obesitas

44–77% catin di Bogor & Jakarta Barat berpengetahuan gizi kurang

72,78% penduduk mengakses internet (terbanyak Gen Z & milenial); 77,57% untuk medsos

±50% unggahan gizi akun populer tidak akurat

- Masa prakonsepsi periode kritis memperbaiki gizi & kesehatan catin sebagai calon ayah dan ibu, tetapi sering diabaikan.
- Dewasa muda aktif mencari info kesehatan di medsos, padahal misinformasi gizi menyebar luas. Dalam HBM, medsos = *isyarat bertindak*, bergantung pada informasi yang dibaca dan cara menilainya.
- Edukasi online catin memberi hasil beragam; intervensi prakonsepsi berbasis HP efeknya masih terbatas.
- Angka berhenti tinggi (*law of attrition*), sehingga cara platform dikembangkan, diubah, dan digunakan perlu dilaporkan.
- Di negara berpenghasilan rendah–menengah, laporan intervensi prakonsepsi online masih terbatas; HP spesifikasi rendah, HP bersama, dan jaringan tidak stabil menjadi hambatan tersering.

Tujuan | **(1)** Mengevaluasi proses implementasi platform web media edukasi SHINING, meliputi penyelesaian pengisian dan mutu data; **(2)** menganalisis pola penggunaan medsos catin dan hubungannya dengan pengetahuan gizi prakonsepsi, sikap berbasis HBM, dan IMT, sebagai dasar pengembangan edukasi gizi prakonsepsi online yang mudah digunakan.

2 Metode

D **Desain:** *cross-sectional* + evaluasi proses, bagian dari riset pengembangan SHINING (model ADDIE)

S **Subjek:** catin 20–40 tahun, kelompok kontrol; rekrutmen via brosur kode QR & WhatsApp; **198** memenuhi syarat, **74** dianalisis (30 laki-laki, 44 perempuan)

I **Instrumen:** pengetahuan 48 butir (baik >80%); sikap 24 butir, 6 konstruk HBM, Likert 4 poin (positif ≥72); FFQ; IPAQ-SF; kuesioner medsos; IMT dari BB/TB isian sendiri (PNPK 2025)

A **Analisis:** Spearman, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, khi-kuadrat/eksak Fisher; hubungan bermakna diuji ulang dengan kontrol peran; sebelum–sesudah perbaikan: eksak Fisher; p<0,05; Python & SPSS

W **Tempat & waktu:** pembinaan catin Kota Binjai, Sumatera Utara; Juli–Oktober 2026

E **Etik:** KEPK Poltekkes Kemenkes Medan No. 01.26.1986/KEPK/POLTEKKES KEMENKES MEDAN 2025; persetujuan elektronik

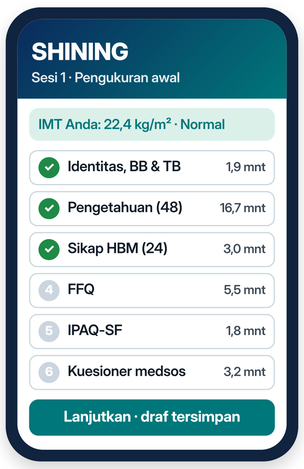
P **Indikator proses:** penyelesaian & lama pengisian (*timestamp*), kiriman ganda, karantina, data hilang; kemudahan dinilai 15 mahasiswa (skala 1–5)

Fokus makalah: proses implementasi (Tujuan 1) & pola medsos (Tujuan 2), data awal kelompok kontrol; evaluasi dampak dilaporkan terpisah.

Alur penelitian (model ADDIE)

1 **Analysis** (Analisis kebutuhan) — Kajian literatur, survei awal, analisis kebutuhan
→ 2 **Design** (Desain media) — Desain konten berbasis *Health Belief Model* (HBM)
→ 3 **Development** (Pengembangan) — Pengembangan platform SHINING dan materi edukasi
→ FOKUS MAKALAH INI: 4 **Implementation** (Implementasi) — Uji coba, rekrutmen peserta, implementasi edukasi online
→ 5 **Evaluation** (Evaluasi) — Analisis proses, pola penggunaan media, dan evaluasi dampak

3.1 Hasil · Platform SHINING — Tujuan 1



Gambar 2. Ilustrasi alur sesi 1 (median waktu pengisian)

- **Web satu halaman, ramah HP:** tanpa unduh aplikasi dan tanpa membuat akun.
- **Masuk dengan nama + nomor HP/WA**, lalu cek kelayakan (catin 20–40 tahun) dan persetujuan.
- **Enam instrumen sesi 1:** identitas (BB & TB), pengetahuan, sikap HBM, FFQ, IPAQ-SF, kuesioner medsos.
- **Umpan balik IMT & status gizi** langsung tampil sebagai informasi sekaligus *engagement*.
- **Tersimpan otomatis ke Google Sheets**; nomor HP/WA sebagai penanda peserta.
- **Kiriman berulang ditandai**; data tak dikenali masuk **lembar karantina** untuk verifikasi manual.
- **Penilaian awal (15 mahasiswa):** kelima aspek mudah (rerata 4,40–4,73 dari 5; total 22,8 ± 2,3 dari 25); terendah pada pengisian kuesioner.



Gambar 3. Tampilan asli SHINING di HP (mulai.edukasi-catin.id)

3.2 Hasil · Pengembangan Iteratif Platform — Tujuan 1



Siklus pengembangan iteratif

Akhir Juli	MASALAH: Persetujuan tidak tersimpan; angka nol nomor HP hilang; status "selesai" hanya di HP	PERBAIKAN: Skrip ditulis ulang (normalisasi nomor, karantina, penanda duplikat); status dikonfirmasi server
Agustus	PENILAIAN AWAL: Kemudahan dan keterbacaan dinilai oleh 15 mahasiswa	CATATAN: Tidak ada masalah besar yang dilaporkan
Awal Oktober	MASALAH: Progres hilang saat berganti telepon; isian kosong	PERBAIKAN: Progres per nomor telepon; validasi isian; kirim ulang otomatis
Pertengahan Oktober	MASALAH: Blok makanan pokok FFQ hilang; halaman awal terlalu banyak tahap	PERBAIKAN: Simpan draf otomatis; blok makanan pokok wajib; persetujuan berlapis
Akhir Oktober	STATUS: Pendaftaran kelompok kontrol ditutup	TINDAK LANJUT: Data dikunci untuk analisis

13,8% kiriman berulang (186 dari 1.344 rekaman)

22/23 rekaman karantina di minggu pertama

26,9%→0% FFQ tanpa makanan pokok setelah simpan draf (p=0,04)

3.3 Penyelesaian Instrumen Sesi 1 — Tujuan 1 — n = 198

TAHAP	DIKIRIM, N (%)	VALID	MEDIAN (RAK), MNT
Persetujuan	171 (86,4%)	–	–
Formulir identitas	161 (81,3%)	160	1,9 (1,1–2,9)
Tes pengetahuan (48 butir)	107 (54,0%)	106	16,7 (10,7–34,4)
Skala sikap (24 butir)	96 (48,5%)	94	3,0 (1,6–4,7)
FFQ	92 (46,5%)	88	5,5 (4,0–7,8)
Kuesioner medsos	82 (41,4%)	80	3,2 (2,1–4,1)
IPAQ-SF	82 (41,4%)	67	1,8 (1,2–2,7)
Keenam instrumen	77 (38,9%)	59	–

Penurunan terbesar (81,3% → 54,0%) **sebelum tes pengetahuan**, instrumen terpanjang (Galesic & Bosnjak 2009). Setelah perbaikan, penyelesaian naik **37,2% → 55,6%** (p=0,137).

Kiriman ganda: dipakai yang paling lengkap. Valid: BB/TB wajar & butir terisi sesuai batas minimal. RAK: rentang antarkuartil.

3.4 Penggunaan Media Sosial — Tujuan 2 — n = 74

INDIKATOR	%
Platform utama: WhatsApp	59,5
Platform utama: TikTok/Instagram	33,8
Akses hampir terus-menerus (±setiap jam)	73,0
Durasi ≥3 jam/hari	51,4
Pernah mencari info prakonsepsi[a]	87,7
Selalu memeriksa kebenaran info[a]	61,6
Sumber: akun nakes/lembaga resmi[b]	75,7
Sumber: influencer[b]	39,2
Pernah tertarik produk yang dipromosikan	71,6

WhatsApp efektif sebagai pengingat kesehatan (Laurence et al. 2025); ketertarikan pada produk promosi perlu diwaspadai (Agustiani et al. 2026).

Subjek: 59,5% perempuan; 60,6% ≤SMA. [a]n=73. [b]Boleh lebih dari satu sumber.

3.5 Hubungan Medsos, Pengetahuan, Sikap HBM, dan IMT — Tujuan 2 — n = 74

Variabel	Pengetahuan	Sikap HBM	IMT
Frekuensi akses	−0,092 (0,436)	0,031 (0,796)	0,038 (0,746)
Durasi harian	0,175 (0,135)	0,199 (0,090)	**−0,331 (0,004)***
Mencari info prakonsepsi	0,057 (0,631)	0,216 (0,066)	−0,181 (0,125)
Memeriksa kebenaran info	0,116 (0,327)	**0,287 (0,014)***	0,042 (0,723)
Platform utama[a]	– (0,088)	**– (0,006)***	– (0,919)
Sumber nakes/resmi[b]	– (0,950)	– (0,456)	**– (0,022)***
Skor pengetahuan	–	**0,414 (<0,001)***	−0,009 (0,939)
Skor sikap	–	–	−0,212 (0,070)

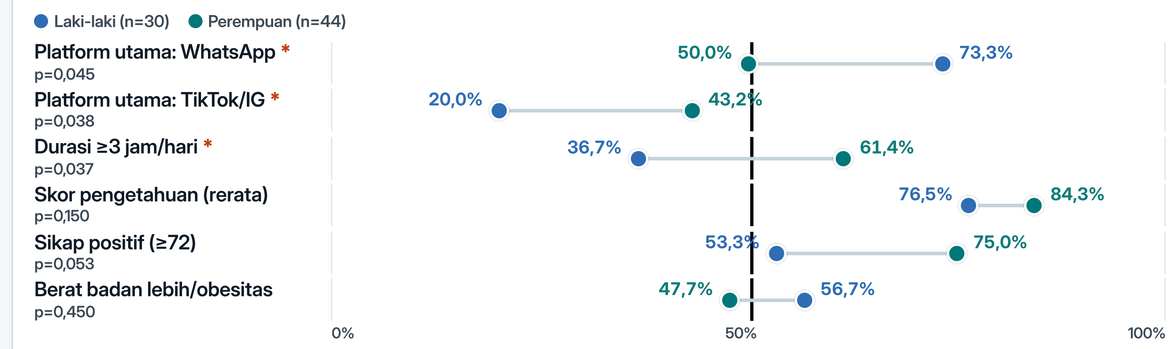
r_s Spearman (p). [a]Kruskal-Wallis; sikap terendah pada pengguna WhatsApp. [b]Mann-Whitney; median IMT 22,5 vs 26,6 kg/m². *p<0,05.

HBM: pengetahuan erat dengan persepsi hambatan (r=0,449), tidak dengan efikasi diri; **hambatan terendah** (68,5%).

Durasi–IMT tetap bermakna setelah dikontrol peran (r parsial=−0,315; p=0,006).

Cara memilih & menilai informasi lebih berperan daripada frekuensi akses (Chen et al. 2018).

3.6 Menurut Peran Catin — Tujuan 2



Catin laki-laki lebih tua dan seluruhnya bekerja; pengetahuan & sikap cenderung lebih rendah (sejalan Zahra et al. 2024), tetapi tidak lebih mudah berhenti (selesai 47,0% vs 47,9%; p=0,910).

*p<0,05 (khi-kuadrat/eksak Fisher; Mann-Whitney untuk skor).

4 Simpulan, Saran & Implikasi

SIMPULAN

- Platform web sederhana dapat dipakai, namun **beban peserta, kiriman ganda, dan kehilangan data tak terlihat** perlu diantisipasi sejak perancangan.
- Penggunaan medsos catin **intensif dan didominasi WhatsApp**.
- Pengetahuan umumnya baik dan berkorelasi dengan sikap HBM, tetapi **>50% catin berat badan lebih/obesitas**.
- IMT lebih rendah & sikap lebih positif berhubungan dengan **sumber kredibel dan memeriksa kebenaran informasi**, bukan frekuensi akses.

Saran: gunakan instrumen ringkas dan pantau data rutin; biasakan catin memeriksa kebenaran informasi & izin edar produk, gunakan referensi kredibel, dan manfaatkan WhatsApp untuk pengingat dan pendampingan.

ENAM IMPLIKASI BAGI EDUKASI GIZI ONLINE

1. **Instrumen ringkas**; tes panjang dipecah ke beberapa kunjungan + simpan-lanjut
2. **Pengingat terjadwal via WhatsApp** untuk menekan angka berhenti
3. **Kiriman ganda & HP bersama** ditangani dengan penanda peserta dan aturan baku
4. **Penyimpanan dikonfirmasi server**; data dipantau setiap minggu
5. **Pesan sesuai peran:** laki-laki via WhatsApp; perempuan juga via TikTok/Instagram
6. **Dokumentasi perubahan** bertanggal; pemisahan kelompok kontrol–intervensi dijaga

Keterbatasan: sampel kecil, BB/TB isian sendiri, eksploratif tanpa regresi, potong lintang; alasan berhenti tidak terekam.

5 Ucapan Terima Kasih

- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai
- Calon Pengantin Kota Binjai
- Seluruh pihak yang berkontribusi

Akses SHINING
mulai.edukasi-catin.id
1 Pindai QR atau buka tautan
2 Isi nama dan nomor WhatsApp
3 Baca persetujuan, lalu mulai

Pustaka utama. Amiri P et al. 2023. BMC Health Serv Res 23:1176 · Atmaka DR et al. 2022. Media Gizi Indones 17(1SP):1–5 · BPS 2025 · Chen X et al. 2018. J Health Commun 23(8):724–734 · Denniss E et al. 2024. IJBNPA 21:16 · Eysenbach G. 2005. JMIR 7(1):e11 · Eysenbach G. 2011. JMIR 13(4):e126 · Faverio M, Sidoti O. 2024. Pew Research Center · Galesic M, Bosnjak M. 2009. Public Opin Q 73(2):349–360 · Janz NK, Becker MH. 1984. Health Educ Q 11(1):1–47 · Lam BT et al. 2025. JMIR 27:e67640 · Laurence MC et al. 2025. Front Digit Health 7:1542006 · Lim MSC et al. 2022. JMIR 24(1):e23656 · Meyerowitz-Katz G et al. 2020. JMIR 22(9):e20283 · Musgrave L et al. 2023. JMIR 25:e41900 · Stephenson J et al. 2018. Lancet 391:1830–1841 · Zahra SS et al. 2024. HPCEJ 3(1)